Issue maternelle et fœtale chez les patientes atteintes d'insuffisance rénale aiguë au cours de la prééclampsie sévère : A propos de 72 cas au centre Hospitalier universitaire de Bogodogo

B. Ouedraogo, P. Ouedraogo, J C. Millogo, A. Ouattara, D. A. Somé

Plan

Introduction

- Objectif
- Matériel et méthodes
- Résultats

Conclusion

Introduction

- L'insuffisance rénale aiguë (IRA) pendant la grossesse constitue un problème de santé publique
- La prééclampsie sévère = 1ère cause d'IRA pdt la grossesse
- Augmentation de la mortalité maternelle et néonatale liée à l'IRA au cours de la grossesse
- Intérêt d'évaluer l'issue maternelle et fœtale des patientes atteintes d'IRA au cours de la prééclampsie

Objectif

1. Décrire l'issue maternelle de l'insuffisance rénale aiguë au cours de la prééclampsie sévère (PES) pendant la période d'étude

2. Décrire l'issue fœtale de l'insuffisance rénale aiguë au cours de la PES pendant la période d'étude

3. Evaluer les facteurs contributifs de la morbidité et mortalité maternelles et fœtales des patientes atteintes d'IRA au cours de la PES pendant la période d'étude

Matériel et méthodes

- **Lieu et date de l'étude**
  - centre hospitalier universitaire de Bogodogo
  - du 1er septembre 2023 au 31 août 2024

- **Type d'étude :** Etude descriptive à visée analytique

- **Population de l'étude**
  - toute patiente présentant une PES compliquée d'insuffisance rénale et
  - admise dans le service

- **Echantillonnage :** exhaustif

Matériel et méthodes

- **Variables dépendantes :**
  - décès maternel,
  - absence de récupération de la fonction rénale à court terme et
  - décès périnatal
- **Variables indépendantes :**
  - caractéristiques sociodémographiques,
  - aspects cliniques, biologiques et thérapeutiques
- **Insuffisance rénale aiguë au cours de la PES :**

  créatininémie ≥ 97µmoles/l

Matériel et méthodes

- **La récupération complète** à court terme a été définie comme
  - une créatinine sérique au 7e jour de l'hospitalisation inférieur à 1,5 fois la valeur initiale ou
  - une normalisation de la créatinémie

- **Analyse :**
  - Logiciel STATA utilisé pour l'analyse des données.
  - Test de Chi^2 a été utilisé en analyse univariée puis
  - régression logistique multivariée afin d'identifier les facteurs associés

Résultats

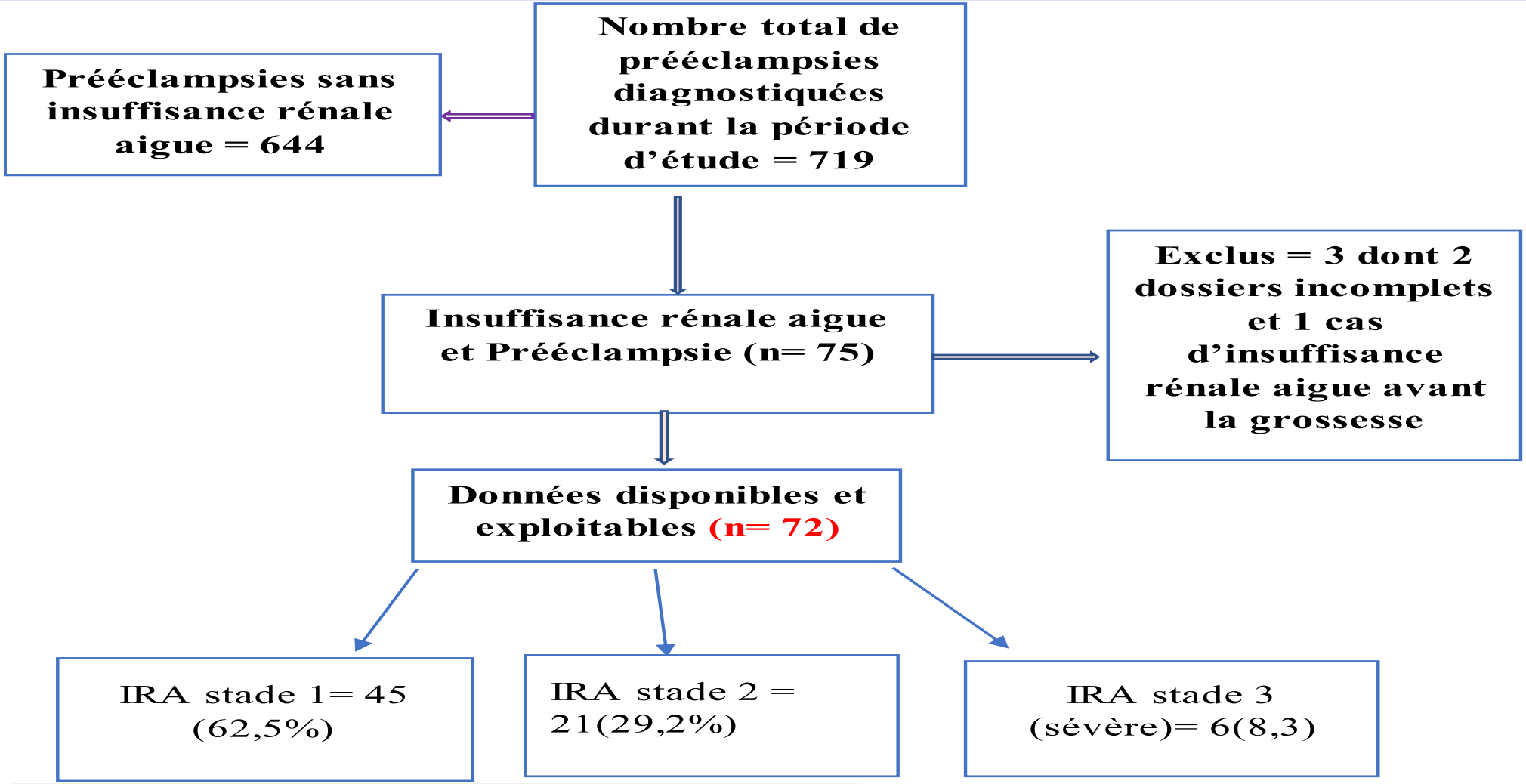

Figure1: Diagramme de flux

Résultats

- Issue maternelle

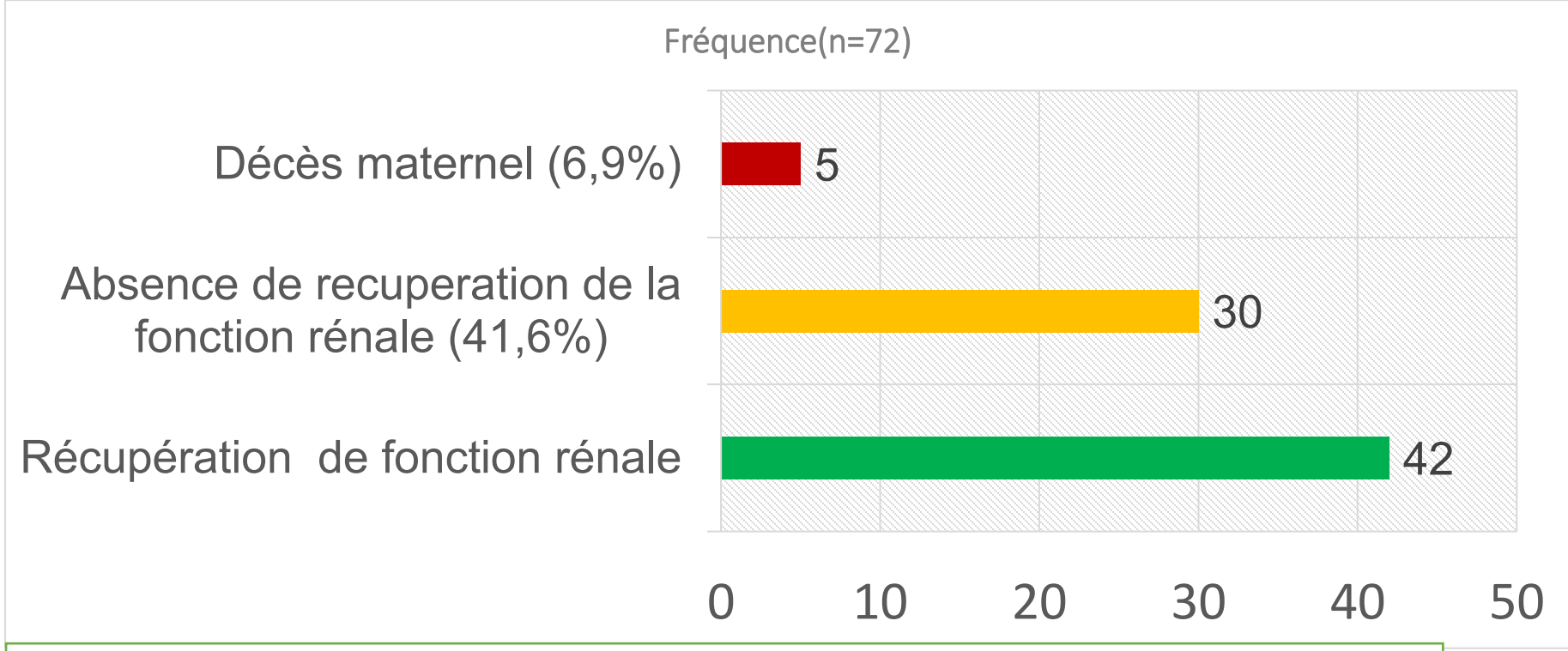

Figure 2: Issue maternelle(n=72)

Résultats

- **Issue fœtale**
  - 27 décès périnataux soit 37,5%
  - 45 Naissance vivantes soit 62,5%

Résultats

Tableau I: Facteurs associés aux décès maternels

Facteurs cliniques	Survivantes		Décès		Odds Ratio	Intervalle de Confiance (95%)	P (value)
	Effectif (n=67)	%	Effectif (n=5)	%			
PAS (mmHg)							
< 160	7	10,45	4	80			
[160, 180[	30	44,78	1	20	0,6	[0,005-0,6]	0,017*
≥ 180	30	44,77	0	0			
Total	**67**	**100**	**5**	**100**			
Sévérité de l'insuffisance rénale							
Non sévère	63	94,03	3	60			
Sévère	4	5,97	2	40	10,5	[1,34-81]	0,025*
Total	**67**	**100**	**5**				

Résultats

- **Facteurs associés à l'absence de récupération de la fonction rénale**
  - La bandelette urinaire à la protéinurie supérieure à 3 croix était significativement associée à l'absence de récupération de la fonction rénale (Odds ratio =**1,6** ; PValue=**0,01**)

Résultats

- **Facteurs associés aux décès périnataux en analyse multivariée**
  - Seule la prématurité était statistiquement associée aux décès périnataux
  - Age gestationnel < 35 SA (Odds ratio = **8** ; P value=**0,01**)

Conclusion

L'issue maternelle et fœtale de l'insuffisance rénale aigue compliquant une prééclampsie était marqué par une forte absence de récupération de la fonction rénale, une étude multicentrique permettrait de cerner les facteurs associés à l'absence de récupération de la fonction rénale afin de prévenir les complications

Merci pour votre attention